

Kolagenózy v praxi: diagnostické a terapeutické výzvy pri systémových autoimunitných ochoreniach

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026

Streamed Up v sérii **RheumaLive** venovanej téme „**Kollagenosen 2026**“ zdôrazňuje, že ide o skupinu chorôb s výrazne odlišnými klinickými prejavmi a s diagnostickými aj terapeutickými rozhodnutiami, ktoré musia reflektovať postihnutie orgánov a individuálnu dynamiku ochorenia. V tomto článku to rozoberám „klinicky“: ako pristupovať k podozreniu na kolagenózu, ako rýchlo zachytiť orgánové ohrozenie a ako rozumne nastaviť liečbu tak, aby zodpovedala riziku.

1) Čo sú kolagenózy a prečo sú „ťažké“

Kolagenózy sú **systémové autoimunitné ochorenia**, pri ktorých imunitný systém postihuje viaceré orgánové systémy naraz alebo sa postihnutie vyvíja postupne. To je aj dôvod, prečo sa diagnóza často odkladá: symptómy môžu byť na prvý pohľad nesúvisiace (napríklad koža, kĺby, pľúca, obličky, svaly, nervový systém).

Aj pri moderných imunologických metódach platí, že:

- prezentácia môže byť nešpecifická alebo „prekrývajúca sa“ (overlap),
- biologická aktivita sa nemusí dokonale zhodovať so subjektívnymi ťažkosťami pacienta,
- a orgánové komplikácie môžu nastúpiť rýchlo.

Práve preto je dôležité uvažovať systémovo už od prvého kontaktu a nastaviť si diagnostický plán, ktorý včas pokrýva „najhoršie scenáre“.

2) Prvý krok: klinická mapa rizík

V praxi je užitočné rozdeliť anamnézu a vyšetrenie do troch hlavných oblastí:

A) Systémové symptómy a zápalová aktivita

Horúčky, chudnutie, únava, artralgie a laboratórne známky zápalu (CRP, sedimentácia) sú len „vodítko“. Samy osebe diagnózu neurčia, ale hovoria, že nejde o izolovaný problém.

B) Orgánové varovné príznaky

Pri kolagenózach môže byť rozhodujúce, či už ide o ohrozenie orgánu. Typické príklady:

- **obličky** (napríklad proteinúria, opuchy, penivosť moču, zhoršenie renálnych parametrov),
- **svaly** (progredujúca svalová slabosť),
- **pľúca** (dyspnoe, kašeľ, intersticiálne zmeny, iné respiračné prejavy),
- a často aj **koža a sliznice** (exantém, fotosenzitivita, ulcerácie).

Povedané jednoducho: diagnostika kolagenóz nie je len o „správnom názve“, ale predovšetkým o tom, či pacienta treba chrániť pred orgánovým poškodením práve teraz.

C) Vzorec príznakov („pattern“) podľa domén

Ak sa príznaky opakujú v typických zostavách, zvyšuje sa pravdepodobnosť určitej podskupiny kolagenózy. Napríklad pri svalovej slabosti treba cielene myslieť na myozitídové spektrum.

3) Diagnostika: čo sa robí a prečo nestačí jeden test

Rheuma-Liga uvádza praktický a na orgány orientovaný diagnostický postup: lekár najprv zhodnotí typické symptómy, doplní laboratóriá a zobrazovanie (napríklad ultrazvuk, RTG), sleduje funkcie postihnutých orgánov a v niektorých situáciách sa pristúpi aj k mikroskopickému vyšetreniu tkaniva (napríklad k biopsii). Dôležité je, že symptómy sa medzi jednotlivými kolagenózami líšia a často si vyžadujú individualizovaný plán.

3.1 Laboratóriá a imunológia: protilátky ako „smerovník“

Autoprotilátky môžu diagnózu významne urýchliť. Rheuma-Liga spomína, že **antinukleárne protilátky (ANA)** sú pri kolagenózach často prítomné a bližšie určenie typu protilátok môže pomôcť rozlíšiť podskupiny. Pri niektorých entitách sa cielene vyšetrujú aj špecifické autoprotilátky (napríklad anti-dsDNA pri aktívnom SLE, prípadne anti-Ro a anti-La pri Sjögrenovom syndróme).

Kľúčové praktické ponaučenie:

- protilátky sú výborný nástroj, ale **nie sú náhradou kliniky**,
- a pozitívny nález bez zodpovedajúceho fenotypu vyžaduje opatrnosť, aby sa pacient zbytočne „neoznačil“.

3.2 Moč a obličkové ukazovatele pri podozrení na nefritídu

Pri podozrení na postihnutie obličiek sa uplatňuje vyšetrenie moču a následné hodnotenie príznakov glomerulárneho poškodenia. Rheuma-Liga uvádza, že zápal pri systémovom lupus erythematosus možno zachytiť vyšetrením moču a prvými viditeľnými varovaniami môžu byť opuchy členkov a pena v moči ako signál vysokého obsahu bielkovín.

3.3 Svaly: klinika plus enzýmy a zobrazenie, niekedy aj EMG a biopsia

Ak dominuje svalová slabosť, Rheuma-Liga spomína, že typické sú zvýšené svalové enzýmy; doplniť ich môže ultrazvuk, MRI, elektromyografia a v prípade potreby aj biopsia svalu. Tento prístup je logický: svalová slabosť má viac príčin a kolagenóзовé myozitídy treba odlíšiť od infekčných, toxických či iných etiológií.

4) V čom je terapeutická výzva: liečiť rýchlo, ale nie naslepo

Streamed Up v popise podujatia uvádza, že sa riešia „diagnostické a terapeutické výzvy“ pri rôznych formách kolagenóz. Aj bez podrobného záznamu jednotlivých prednášok sa dá medicínsky rozumne zhrnúť, čo tieto výzvy typicky znamenajú:

1. **Rýchlosť rozhodnutia.** Pri orgánovo ohrozujúcich formách nie je priestor na dlhé diagnostické váhania. Ak sú jasné známky aktivity a rizika, terapia sa zvyčajne začína podľa závažnosti, pričom diagnóza sa priebežne spresňuje.
2. **Vyváženie účinnosti a bezpečnosti.** Imunosupresia môže dramaticky zlepšiť prognózu, ale zvyšuje riziko infekcií, metabolických komplikácií a nežiaducich účinkov. Preto treba vopred myslieť na prevenciu a monitorovanie.
3. **Stratifikácia podľa orgánového postihnutia.** Nie je to jedna liečba pre všetkých. Taktika sa mení podľa toho, či ide o kožné, kĺbové, pľúcne alebo obličkové postihnutie.
4. **Dlhodobé riadenie.** Cieľom nie je iba krátkodobá remisia, ale aj jej udržanie bez relapsu a minimalizácia kumulatívnej toxicity liečby.

5) Praktický diagnosticko-terapeutický rámec (čo by mal vedieť klinik)

Nasledujúci rámec je praktický a „aplikovateľný“; nie je to presný algoritmus jedného konkrétneho programu.

Krok 1: Potvrdiť, že nejde o jednorazový incident

Zhodnoťte trend príznakov, zápalové parametre a to, či existujú „orgánové“ príznaky. Ak dominuje napríklad nefritída alebo myozitída, nejde o asymptomatický nález.

Krok 2: Cieľiť diagnostiku na orgány

Zámer: odhaliť postihnutie obličiek, svalov, pľúc a iných systémov tak, aby liečba nebola zbytočne oneskorená a aby bola adekvátne riziku. V praxi to typicky znamená:

- vyšetrenie moču pri podozrení na nefritídu,
- svalové enzýmy, zobrazovanie a doplnenie podľa potreby pri slabosti,
- a ďalšie ciele vyšetrenia podľa kliniky.

Krok 3: Imunologická stratifikácia

Použite ANA a doplnkové protilátky na orientáciu, pričom výsledok vždy interpretujte v kontexte pacienta.

Krok 4: Multidisciplinárne rozhodnutie

Pri aktívnom orgánovom postihnutí je často potrebná spolupráca reumatológa, nefrológa, pneumológa alebo neurológa podľa domény. Tým sa skracuje cesta k správnej intervencii.

6) Čo s „nejasnými“ prípadmi

Keď je klinika rozporuplná a protilátky sú hraničné alebo nešpecifické, je to typická situácia, v ktorej sa ľahko urobí diagnostická chyba v oboch smeroch:

- buď sa významná aktivita podcení,
- alebo sa pacient zbytočne lieči, hoci ide o inú príčinu.

V takých prípadoch rozhoduje:

- časový priebeh,
- kvalita monitorovania (opakované hodnotenie orgánov),
- a zrozumiteľný plán, čo je ďalší krok, ak sa aktivita zhorší.

7) Záver

Kolagenózy sú skupina systémových autoimunitných ochorení, pri ktorých nerozhoduje jediné laboratórne vyšetrenie, ale premyslený, orgánovo orientovaný prístup. Podujatie „Kollagenosen 2026“ v rámci RheumaLive poukazuje na to, že v tejto oblasti existujú významné diagnostické aj terapeutické výzvy. Klinicky sa to prejavuje potrebou rýchlo zachytiť orgánové ohrozenie, správne interpretovať imunologické nálezy a liečbu prispôbiť riziku a dynamike ochorenia. Praktický rámec z diagnostiky (moč, svaly, autoprotiľátky, doplnenie podľa domény) a z bezpečnej terapie je základ, aby sme pacienta ochránili pred poškodením orgánov a zároveň minimalizovali liečebnú záťaž.

Zdroj (podujatie): *streamed-up.com*, „Kollagenosen 2026“ (RheumaLive, 2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj (klinický prehľad diagnostiky kolagenóz): Rheuma-Liga, „Kollagenosen“. [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kolagenozy-v-praxi-diagnosticke-a-terapeuticke-vyzvy> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.